

MODULE LÉSIONS DES TISSUS MOUS

Ce qu'il faut retenir

Aide-mémoire du volet en ligne

Chaque leçon du module en ligne est ramenée à ses quatre ou cinq idées essentielles.
Ce document ne remplace ni le manuel, ni les capsules, ni la pratique en classe.

Les lésions des tissus mous sont les blessures les plus fréquentes en régions isolées, et souvent les seules que vous prendrez en charge du début à la fin, sans relais médical.

Trois principes traversent tout le module : maîtriser le saignement, prévenir l'infection, favoriser la cicatrisation.

CONTENU DU MODULE — SEPT LEÇONS

INTRODUCTION

00 Introduction au chapitre

COMPRENDRE ET ÉVALUER

01 Le système tégumentaire

02 L'évaluation

PRENDRE EN CHARGE

03 Les lésions spécifiques

04 Les ampoules

05 Les brûlures

S'ÉQUIPER

06 Les trousses de premiers soins

REPÈRES EN BAS DE CHAQUE FICHE

Manuel de l'apprenant : section correspondante dans l'encyclopédie en ligne, accessible après authentification via siriusmedx.com/manuel.

Manuel terrain : pages du guide de poche à emporter en région isolée.

Surligné en jaune : référence ou formulation à confirmer avant diffusion.

00

Introduction au chapitre

Les blessures les plus fréquentes en régions isolées, souvent prises en charge de bout en bout par le secouriste

Pourquoi ce chapitre : une plaie mal nettoyée le jour 1 devient une infection le jour 3 et une évacuation le jour 5. Ici, le secouriste fait ce qu'un urgentologue ferait, avec ce qu'il a dans son sac.

- 1 Trois blocs : comprendre, prendre en charge, s'équiper.** La peau et sa réponse à la blessure, puis l'évaluation par le SEP ; les lésions particulières, les ampoules et les brûlures ; enfin le matériel que vous utiliserez tout au long du chapitre.
- 2 Trois principes, toujours dans cet ordre.** Maîtriser le saignement, prévenir l'infection, favoriser la cicatrisation. Chaque geste du module se rattache à l'un des trois.
- 3 Le choc n'est jamais loin.** Une hémorragie externe ou interne donne un choc hypovolémique ; une brûlure étendue aussi, par perte de plasma ; une infection avancée, un choc septique. Demandez-vous à chaque cas : quel type de choc ?
- 4 La profondeur se lit par les couches anatomiques.** Épiderme, derme, hypoderme, fascia profond. Ce qui est atteint sous la peau (tendon, nerf, vaisseau, os, articulation) détermine le risque et la décision d'évacuer, bien plus que la longueur de la plaie.
- 5 En ligne les notions, en classe les mains.** Irrigation, packing, pansements, bandages, drainage d'ampoule, gestion d'une trousse à deux : tout cela se pratique en présentiel sur des plaies maquillées.

01

Le système tégumentaire

Comprendre la peau pour évaluer ce qui est atteint

La peau est un organe : barrière contre les microbes et la perte d'eau, régulateur de température, organe du toucher. Chaque plaie est une brèche dans ces fonctions, et le corps a un plan pour la refermer.

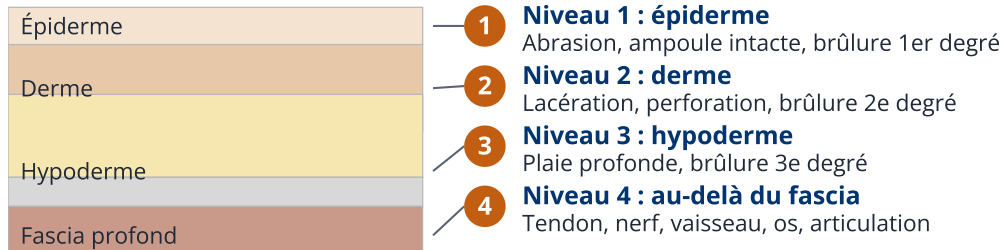


Figure 1 — Quatre niveaux, quatre frontières anatomiques.

- 1 **Quatre niveaux, quatre frontières anatomiques.** Épiderme (couche protectrice, sans vaisseaux), derme (vaisseaux, nerfs, glandes, follicules), hypoderme (graisse, gros vaisseaux, coussin), puis le fascia profond qui recouvre muscles, tendons, os et articulations. Une lésion de niveau 4 atteint les structures profondes.
- 2 **Arrêter le saignement : le corps commence sans vous.** Rétraction des vaisseaux sectionnés, vasoconstriction, formation du clou plaquettaire, puis caillot. Votre pression directe donne le temps à ces mécanismes d'agir ; elle ne les remplace pas.
- 3 **Puis l'inflammation, qui est normale.** Rougeur, chaleur, enflure et douleur des premiers jours sont la réponse de nettoyage du corps. Elles deviennent inquiétantes si elles augmentent après 48 heures, s'étendent au-delà des bords, ou s'accompagnent de pus, de fièvre ou de traînées rouges.
- 4 **Régénération : humide, oxygénée, nourrie, immobile.** Les nouveaux tissus poussent dans un milieu humide (jusqu'à 30 % plus vite qu'à l'air libre), avec un bon apport sanguin, et sans être réouverts à chaque mouvement.
- 5 **Ce qui nuit à la cicatrisation.** Interruption de l'apport sanguin (froid, compression, bandage trop serré, tabac), stress mécanique (mouvement, tension sur les bords), infection (abcès, infection anaérobie des plaies profondes et fermées), et l'état général : dénutrition, diabète, déshydratation, épuisement.

02

L'évaluation

Le SEP appliqué à une lésion des tissus mous

La plaie qui saigne attire l'œil ; le SEP vous ramène à l'ordre. Une hémorragie extrême se contrôle à l'examen primaire, tout le reste attend l'examen secondaire. Et une plaie peut cacher une fracture, une lésion nerveuse ou tendineuse.

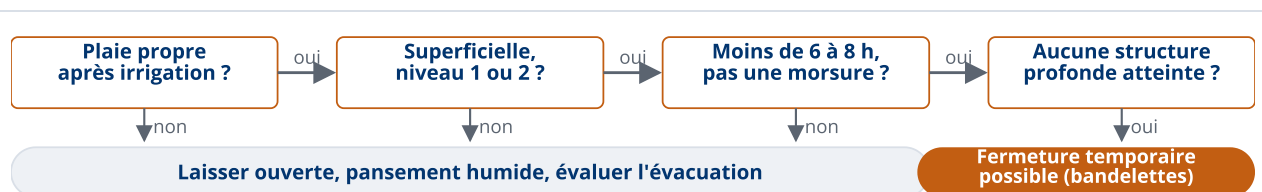


Figure 2 — Refermer ou non sur le terrain : quatre questions, reprises de l'aide à la décision du manuel terrain (page 91).

- 1 **Décrire la plaie en quatre mots : force, type, profondeur, saignement.** Force contondante ou pénétrante (arme à feu : entrée, sortie, trajet). Plaie fermée ou ouverte (abrasion, lacération, perforation, avulsion, amputation). Niveau de profondeur 1 à 4. Saignement capillaire, veineux ou artériel, et signes d'hémorragie interne.
- 2 **Évaluer ce qu'il y a sous la plaie.** CSM en aval (circulation, sensibilité, motricité), mouvement contre résistance pour les tendons, sensibilité fine pour les nerfs, douleur osseuse ou articulaire à la palpation, corps étranger. Une plaie sur une articulation ou en regard d'un os est une plaie à risque élevé.
- 3 **Maîtriser le saignement.** Pression directe ferme et continue ; si elle ne suffit pas, packing de la plaie avec de la gaze (hémostatique si disponible) en visant le point qui saigne, quitte à retirer et recommencer pour mieux cibler la source ; garrot pour une hémorragie de membre incontrôlable. Notez l'heure de tout garrot.
- 4 **Prévenir l'infection : irriguer, beaucoup.** Nettoyez la peau autour, puis irriguez l'intérieur de la plaie à l'eau potable sous pression (seringue) en grande quantité, retirez les débris à la pince, explorez. Rasez au besoin, ne frottez pas le fond de la plaie avec un antiseptique. Une plaie sale ou à risque élevé ne se referme pas sur le terrain.
- 5 **Favoriser la cicatrisation et décider de l'évacuation.** Plaie humide, pansement sec et propre changé dès qu'il est souillé, ou pansement occlusif pour le long terme ; bandelettes de suture uniquement pour une plaie superficielle, propre, sans saignement. Évacuation si structures profondes atteintes, plaie très contaminée, morsure, plaie du visage, de la main ou du périnée, corps étranger enfoncé, ou signes d'infection qui progressent.

03

Les lésions spécifiques

Chaque type de plaie a ses particularités

Les principes ne changent pas, les détails oui. Cette leçon couvre les plaies fermées et quelques situations classiques du terrain qui demandent un geste particulier ou une décision particulière.

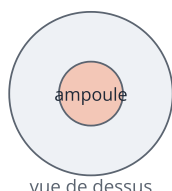
- 1 **Contusion : froid, compression, élévation, et un doute.** Un hématome qui grossit vite, une douleur disproportionnée ou une atteinte des CSM font suspecter une fracture, une lésion vasculaire ou un syndrome de loge. Réévaluez.
- 2 **Écrasement : le danger est ce qui suit.** Une compression prolongée d'un membre libre, au relâchement, des toxines qui menacent le cœur et les reins. Évaluez, immobilisez, traitez le choc, évacuez. Une atteinte profonde peut être sévère sous une peau presque intacte.
- 3 **Bague et enflure : retirer avant qu'il soit trop tard.** Toute blessure de la main ou du doigt fait retirer bagues et bracelets immédiatement, avant l'œdème. Technique du fil ou de la ficelle enroulée en classe ; coupe de la bague en dernier recours.
- 4 **Hématome sous-unguéal : drainer pour soulager.** Le sang sous l'ongle crée une pression très douloureuse. Un petit trou dans l'ongle (trombone chauffé ou aiguille) libère la pression, dans les 24 à 48 heures suivant la blessure.
- 5 **Hameçon : pousser et couper, ou retirer par traction.** Si la pointe et l'ardillon sont proches de la surface : pousser à travers, couper l'ardillon, retirer à reculons. Sinon, technique de la ficelle : pression sur l'œillet et traction vive dans l'axe. Jamais près de l'œil : stabilisez et évacuez. Vérifiez le tétanos.

04

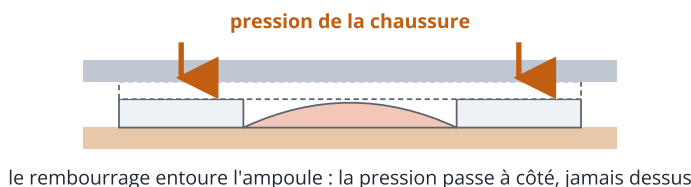
Les ampoules

Reconnaître le point chaud avant qu'il devienne une ampoule

L'ampoule de friction est une lésion des tissus mous : les couches supérieures de l'épiderme se décollent sous l'effet du frottement et de la pression, et l'espace se remplit de liquide. C'est la blessure qui arrête le plus d'expéditions, et la plus évitable.



vue de dessus



Beigne : couche épaisse
découpée autour, jamais
posée sur le point chaud.

Figure 3 — Le rembourrage entoure l'ampoule : la pression passe à côté, jamais dessus.

- 1 **Le point chaud est le moment d'agir.** Rougeur, chaleur, sensation de brûlure localisée. Arrêtez-vous, retirez la chaussure, corrigez la cause (chaussette humide, lacet, pli, gravier, chaussure trop serrée) et protégez la zone avant de repartir.
- 2 **Prévention : réduire la friction, pas ajouter de volume.** Chaussures faites, chaussettes adaptées et sèches, crème antifriction sur les zones sensibles, ruban mince (Adhesive Knit, ruban chirurgical) en prévention. La moleskine épaisse posée préventivement augmente la pression dans une chaussure ajustée dès que le pied gonfle : réservez le rembourrage aux ampoules formées.
- 3 **Ampoule intacte : protéger, et drainer si elle gêne.** Petite et non tendue : la laisser, protéger avec un pansement en beigne. Grosse, tendue ou douloureuse à la marche : drainer proprement à la base avec une aiguille désinfectée, sans retirer la peau, puis pansement.
- 4 **Ampoule ouverte : c'est une plaie.** Nettoyez, irriguez, gardez humide (hydrogel type Second Skin ou pansement hydrocolloïde), pansement en beigne autour pour répartir la pression, fixez avec un ruban qui tient à l'humidité. Surveillez l'infection.
- 5 **Prise en charge à long terme.** Vérifiez et refaites le pansement chaque jour et à chaque fois qu'il se décolle ou se mouille. Une ampoule infectée (rougeur qui s'étend, pus, douleur croissante, fièvre) chez un marcheur peut justifier une évacuation. Trousse ampoules : aiguille, antiseptique, hydrogel, ruban mince, ciseaux.

05

Les brûlures

Reconnaître et classer avant de traiter

Une brûlure est une lésion des tissus mous par la chaleur, le froid, un produit chimique, l'électricité ou le rayonnement. Sa gravité tient à trois choses : la profondeur, l'étendue et l'emplacement. Le choc associé est hypovolémique, par perte de plasma.

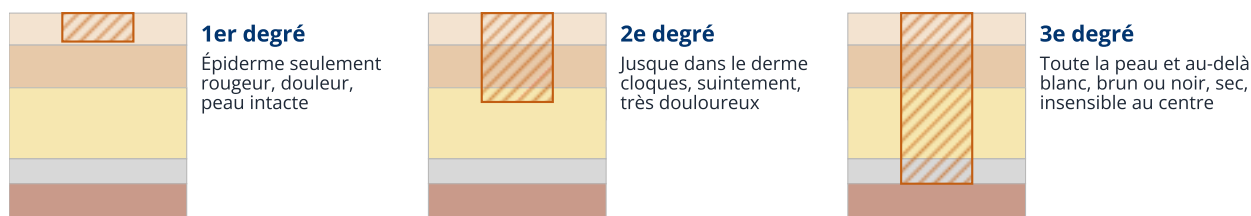


Figure 4 — La profondeur hachurée définit le degré, pas l'étendue.

- Trois degrés, lus sur la peau.** 1er degré : rougeur, douleur, peau intacte (coup de soleil). 2e degré : cloques, suintement, très douloureux, atteint le derme. 3e degré : blanc, brun ou noir, sec, insensible au centre, traverse toute la peau. La classification se fait sur des critères cliniques, pas sur un pourcentage de surface.
- Les premiers soins sont les mêmes pour toutes.** Éloignez de la source, précautions universelles, ABC. Refroidissez avec beaucoup d'eau fraîche (pas glacée), retirez vêtements non adhérents, bagues et bijoux avant l'enflure. Ne retirez jamais ce qui colle. Neige et glace avec grande prudence.
- Selon le degré.** 1er degré : hydratant type aloès sur peau intacte. 2e et 3e degré : irriguez délicatement, ne crevez pas les cloques, pas de crème sur une cloque ouverte, pansement occlusif pour brûlure (hydrogel) ou compresses stériles sèches. Onguent antibiotique seulement si l'évacuation vers les soins dépasse 24 heures.
- Hydratation, chaleur, douleur.** Une brûlure étendue perd du plasma et de la chaleur : faites boire autant que toléré, traitez le choc et prévenez l'hypothermie. Le froid appliqué soulage la douleur mais refroidit la victime : refroidissez la brûlure, réchauffez la personne.
- Quand évacuer.** 2e degré sur plus de 15 % de la surface corporelle (10 % chez l'enfant ou la personne âgée), 3e degré étendu, brûlure au visage ou signes d'inhalation (toux, suie, voix rauque, poils nasaux brûlés), brûlures profondes des mains, pieds, organes génitaux, yeux, articulations, brûlures chimiques ou électriques (lésions internes invisibles, arythmies).

06

Les trousses de premiers soins

Le matériel que vous utiliserez tout au long du chapitre

Une trousse n'est pas une liste, c'est un plan. Elle se construit selon la durée, le nombre de participants, le niveau de formation, l'environnement et les risques anticipés. Et elle ne sert que si vous la connaissez avant d'en avoir besoin.

- 1 Cinq familles de fournitures pour les tissus mous.** Pansements stériles (compresses, gaze non adhérente), pansements non stériles (rembourrage), bandages (rouleau de gaze, élastique, triangulaire), adhésifs (ruban de coton, ruban chirurgical, teinture de benjoin), pansements techniques (bandelettes de suture, occlusifs transparents, hydrogel, hydrocolloïdes).
- 2 Les outils de nettoyage.** Seringue d'irrigation, pince fine, ciseaux, gants en quantité, solution antiseptique sans alcool pour la peau autour, eau potable pour l'intérieur de la plaie. Une gourde à bec verseur fait une bonne irrigation improvisée.
- 3 Choisir sa trousse selon son activité.** Canot, escalade, motoneige, chantier, randonnée : les mécanismes de blessure diffèrent, le contenu aussi. Pensez aux ampoules, aux brûlures de réchaud, aux mains. Emballez en modules étanches et étiquetés.
- 4 Se familiariser avant le module en présentiel.** Ouvrez chaque pansement au moins une fois, sachez comment il s'applique et où il est rangé. En classe, vous gèrerez la trousse à deux : l'un traite, l'autre fournit et garde le matériel propre.
- 5 Gérer la trousse pendant et après.** Ne contaminez pas la trousse avec des gants souillés, isolez les déchets, nettoyez les outils, refaites l'inventaire après chaque usage, notez ce qui manque. Une trousse entamée et non refaite est une fausse sécurité.